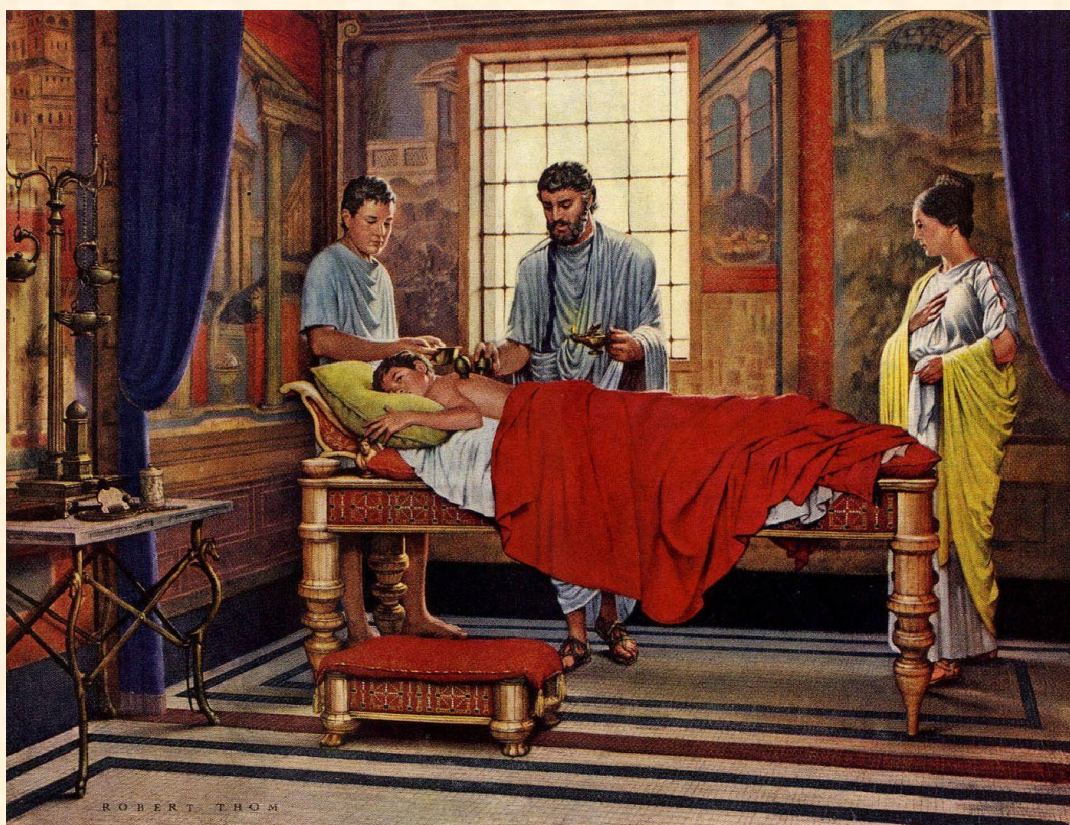


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11^ο

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ



«Espice, Adspice, Prospice».
«Εξέταζε το παρελθόν, εξέταζε το παρόν, εξέταζε το μέλλον».

Λατινικό απόφθεγμα.

ΟΞΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ Ή ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ

Γενικά: Η οξεία Φαρυγγο-Αμυγδαλίτιδα είναι συχνά αποτέλεσμα βακτηριακής ή ιογενούς λοίμωξης, κυρίως από β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο ομάδος A (GABHS) και από ιούς, όπως ρινοϊοί, αδενοϊοί, ιοί-corona, coxsackie, κ.ά. Εμφανίζεται κυρίως τους χειμερινούς μήνες και στην αρχή της άνοιξης. Η μετάδοση γίνεται κυρίως με την επαφή των χεριών και με τις ρινικές εκκρίσεις. Ο χρόνος επώασης κυμαίνεται μεταξύ 24-72 ωρών. Η μολυσματικότητα είναι μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της νόσου και όχι κατά τη διάρκεια της φορίας.

Κλινική εικόνα: Μπορεί να εμφανιστεί χωρίς εξίδρωμα ή σε ελαφρά εξιδρωματική μορφή με ρινική καταρροή (*κόρυζα*), επιπεφυκίτιδα, βήχα ή βράγχος φωνής, κακουχία με χαμηλό πυρετό, πονοκέφαλο, αλλά χωρίς βαριά κλινική εικόνα, οπότε κατά κανόνα είναι ιογενής. Σε σοβαρές περιπτώσεις οξείας φαρυγγο-αμυγδαλίτιδας υπάρχει άφθονο πυώδες εξίδρωμα, δυσκαταποσία, υψηλός πυρετός, έντονη κακουχία, καταβολή δυνάμεων, υπνηλία, επώδυνοι διογκωμένοι πρόσθιοι τραχηλικοί λεμφαδένες, οπότε βάσιμα υποπτευόμαστε λοίμωξη από GABHS. Στους εφήβους και σε νεαρούς ενήλικες έντονη εξιδρωματική κυνάγχη με πυρετό, γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια, κόπωση, ανορεξία, ηπατο-σπληνομεγαλία και η ανεύρεση στη γενική αίματος άτυπων λεμφοκυττάρων > 10%, κατευθύνει τη διάγνωση προς Λοιμώδη Μονοπυρήνωση. Σε αμφίβολες περιπτώσεις πρέπει να αναζητηθούν τα αντισώματα VCA-IgM για τον ιό Epstein-Barr και να γίνει διαφοροδιάγνωση από γρίπη, λοίμωξη Covid-19, HIV πρωτολοίμωξη, ερπητική ουλοστοματίτιδα, κυνάγχη Vincent, ερπητική κυνάγχη, κ.ά.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Επί ιογενούς λοίμωξης (*το πλέον σύνθηες*), ουδεμία αντιμικροβιακή αγωγή απαιτείται.
2. Για την απόφαση χορήγησης αντιβιοτικής θεραπείας τηρούνται τα **κριτήρια του Centor** και για την άμεση εργαστηριακή διάγνωση χρησιμοποιείται το test ταχείας ανίχνευσης του αντιγόνου του Str. pyogenes - **Strep test** (ευαισθησία 85-91%, ειδικότητα 90-96%).
3. Σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα σήμερα τέσσερα κριτήρια του Centor, δηλαδή:

i. Πυρετός ($\theta > 38,3^{\circ}\text{C}$),	iii. Επώδυνοι τραχηλικοί λεμφαδένες,
ii. Πυώδες εξίδρωμα αμυγδαλών,	iv. Απουσία βήχα (και ρινίτιδος),

είναι δυνατόν να αποφασίσουμε τη στρεπτοκοκκική αιτία της κυνάγχης, ως ακολούθως:
 - Επί απουσίας όλων των κριτηρίων ή παρουσίας μόνο ενός (1) κριτηρίου, αποκλείεται σχεδόν με βεβαιότητα ο GABHS και δεν πρέπει να χορηγηθούν αντιβιοτικά.
 - Επί παρουσίας και των τεσσάρων (4) κριτηρίων, επιβεβαιώνεται ως αιτία ο GABHS.
 - Επί υπάρξεως δύο (2) ή τριών (3) κριτηρίων, πρέπει να διενεργείται Strep test.
4. Επί παρουσίας φλεγμονώδους στρεπτοκοκκικού εξιδρώματος στα παρίσθημα, δίδεται:
 - **Πενικιλίνη V (Ospen)**, 1.500.000 IU/8ωρο (po) [ή 20 ml oral susp. Ospen x 3 (po)], μία ώρα προ του φαγητού, για 10 ημέρες, με κλινική επαναξιολόγηση σε 48 ώρες, ή
 - **Αμοξικιλίνη (Amoxil)**, 500 mg x 3 (po), για 10 ημέρες, ή
 - **Κλαριθρομυκίνη (Klaricid)**, 250-500 mg x 2 (po), για 10 ημέρες, ή
 - **Αζιθρομυκίνη (Zithromax)**, 500 mg/24ωρο (po), για 5 ημέρες, ή 2 gr (po), εφάπαξ.
5. Επί υποψίας περιαμυγδαλικού αποστήματος, χορηγείται **Αμοξικιλίνη + Κλαβουλανικό (Augmentin)** 1 gr 1x3 (po), ή **Αμπικιλίνη + Σουλμπακτάμη (Begaline)** 375 mg, 1x3 (po), για 10 ημέρες και συνιστάται άμεση χειρουργική παροχέτευση του αποστήματος.
6. Επί υποτροπιάζουσας ή/και αποδεδειγμένης (με Strep-test) Στρεπτοκοκκικής κυνάγχης, ή επί αλλεργίας ή επί αποτυχίας των κλασικών αντιβιοτικών, χορηγείται **Κλινδαμυκίνη (Dalacin)** 300 mg, 1x3 ή 1x4 (po), για 7-10 ημέρες, μαζί με προβιοτικά που τροποποιούν ενίοτε την εντερική χλωρίδα: *Ultralevure* 250mg, 1x2, (po), για την πρόληψη διαρροιών.
7. **Επί πυρετού, στο ΤΕΠ:** 1 fl *Combogesic* (1 g/300 mg), σε έγχυση (iv), εντός 15 λεπτών.
Υποστηρικτική αγωγή: Παρακεταμόλη 500-650 mg x 4 και σιρόπι Μεφαιναμικού οξέος (*Ponstan*) 10 ml (500 mg) x 2, για τον πυρετό και τον πόνο, για 3-5 ημέρες. Γαργαρισμοί με αλατόνερο ή μαγειρική σόδα, ανά 6-8 ώρες. Σιρόπι Octonion 10 ml x 3, για 5 ημέρες.